

LA MALADIE ULCÉREUSE GASTRO - DUODÉNALE

2025-2026

Dr TORCHI N.

01. Définition

- - L' ulcère gastrique ou duodénal se définit comme une **perte de substance atteignant en profondeur la musculuse** , avec constitution d'une cicatrice scléreuse lors de la cicatrisation.
- - Affection plurifactorielle et chronique évoluant spontanément par poussées.
- Prise en charge de la MUGD a été révolutionnée par la découverte de Hp

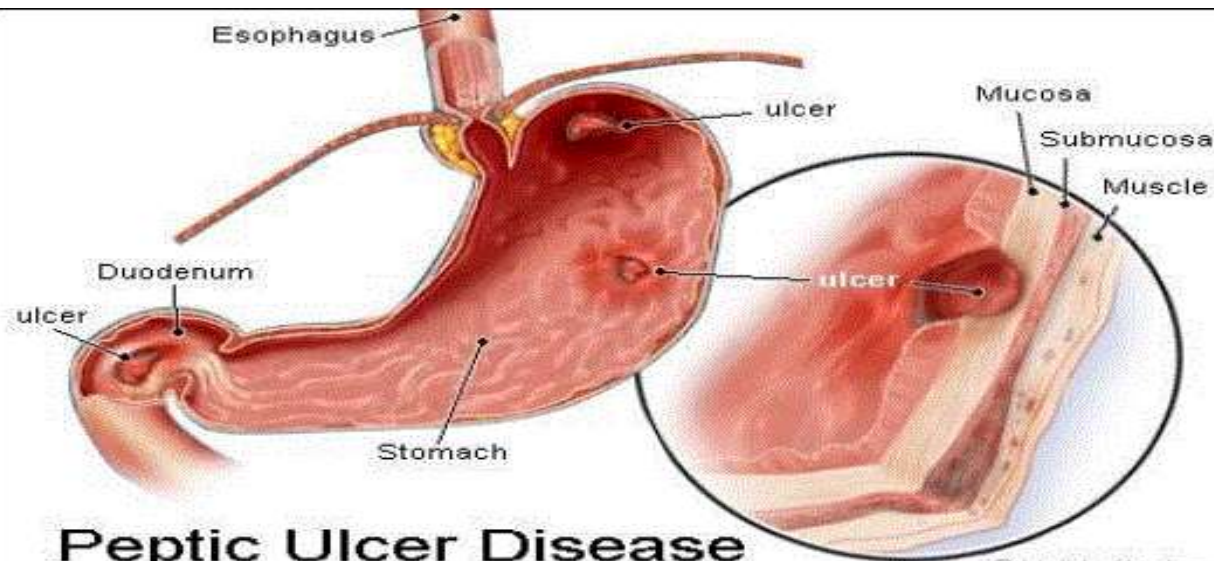
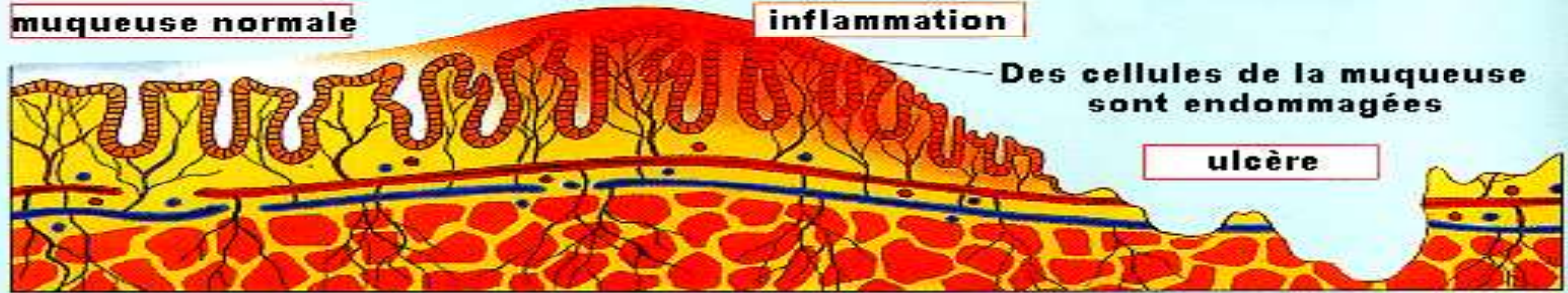
Formation de l'ulcère

muqueuse normale

inflammation

Des cellules de la muqueuse sont endommagées

ulcère



Peptic Ulcer Disease

A circumscribed ulceration of the gastrointestinal mucosa occurring in areas exposed to acid and pepsin and most often caused by *Helicobacter pylori* infection. (Uphold & Graham, 2003)

02. épidémiologie

- - Prévalence : environ 8 % en diminution depuis les années 1990
- - L'ulcère duodénal est 2 à 4 fois plus fréquent que l'ulcère gastrique
- - Sex-ratio :
prédominance masculine(3H / 1F)
- - Age : UD: sujet jeune
 UG: peu fréquent avant 40 ans (pic vers 55-65ans)
- mortalité : UD : 1% , UG : 2,5%

03. ANAPATH

- Perte de substance profonde recouverte d'une fausse membrane jaune
- unique, parfois multiples
- taille variable
- siège : antre (UG), bulbe (UD)
- **Histologie :**
 - bloc scléro-atrophique au fond de l'ulcère
 - endartérite scléreuse
 - hyperplasie nerveuse

04. physiopathologie

- MUGD : maladie **plurifactorielle** résultant d'un déséquilibre des 3 facteurs physiopathologiques (**agression, défense & réparation**)

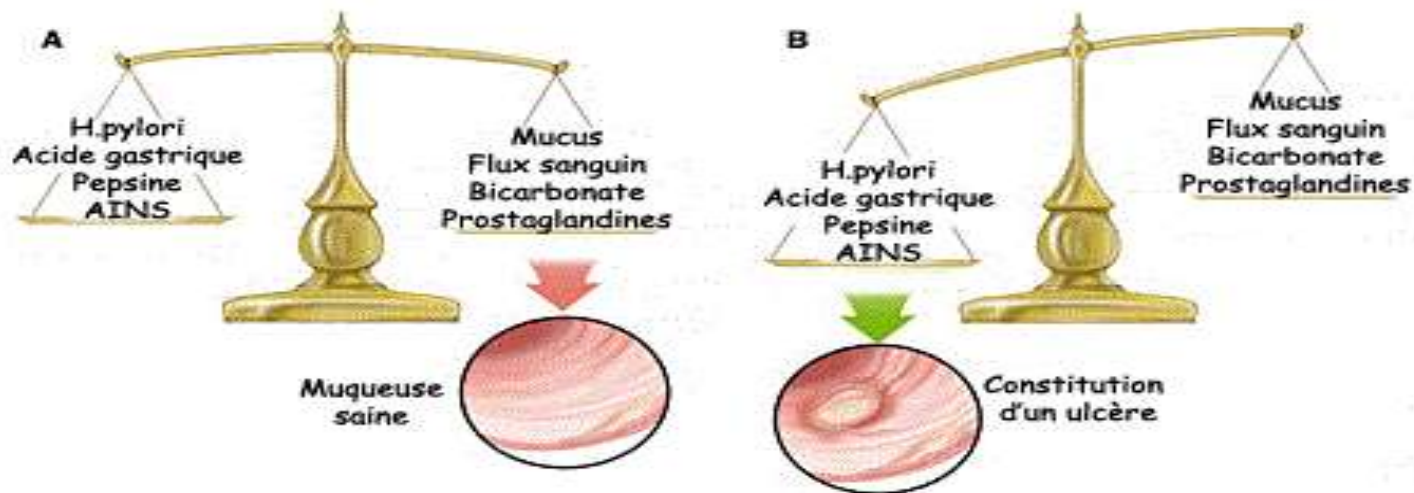


Figure n°1 : (A) et (B) Balance entre les facteurs protecteurs et agressifs.

(Copyright Johns Hopkins Hospital - Traductions Hepatoweb.com)

1. Facteurs de défense:

- la couche de mucus riche en bicarbonates
- l'épithélium
- processus de réépithélialisation, appelé restitution ou reconstruction
- **Vascularisation muqueuse** : favorise la trophicité des cellules épithéliales et épuration des ions H^+
- **Rôle des PG** : inhibent SGA, stimulent la sécrétion de mucus, de bicarbonates et augmentent le flux sanguin de la muqueuse gastrique.
- **Monoxyde d'azote(NO)** : un effet vasodilatateur et cytoprotecteur

2)Facteurs d'agression:

1)Sécrétion gastrique acide (SGA):

- En cas d'ulcère duodénal:+++

- Augmentation de la sécrétion acide au cours de l'ulcère duodénal

- En cas ulcère gastrique:

SGA est normale ou diminuée:

- en cas d'un UG proximal :diminution de la SGA par masse cellulaire pariétale/Atrophie glandulaire)
- en cas d'un UG distal (pré-pylorique) =mécanisme UD

2) Sécrétion peptique:

Le débit de sécrétion peptique est augmenté dans les ulcères en poussée et normal lors de la rémission.

3) Troubles de la motricité:

en cas d'un UD : Accélération de la vidange gastrique

en cas d'un UG : Ralentissement de la vidange gastrique

4) Radicaux libres oxygénés (RLO):

Au cours de la phase aiguë de la MUGD, les macrophages produisent des RLO , entraînant une mort cellulaire

5) Sécrétion de gastrine/histamine : augmente la SGA

• 3) Facteurs étiologique :

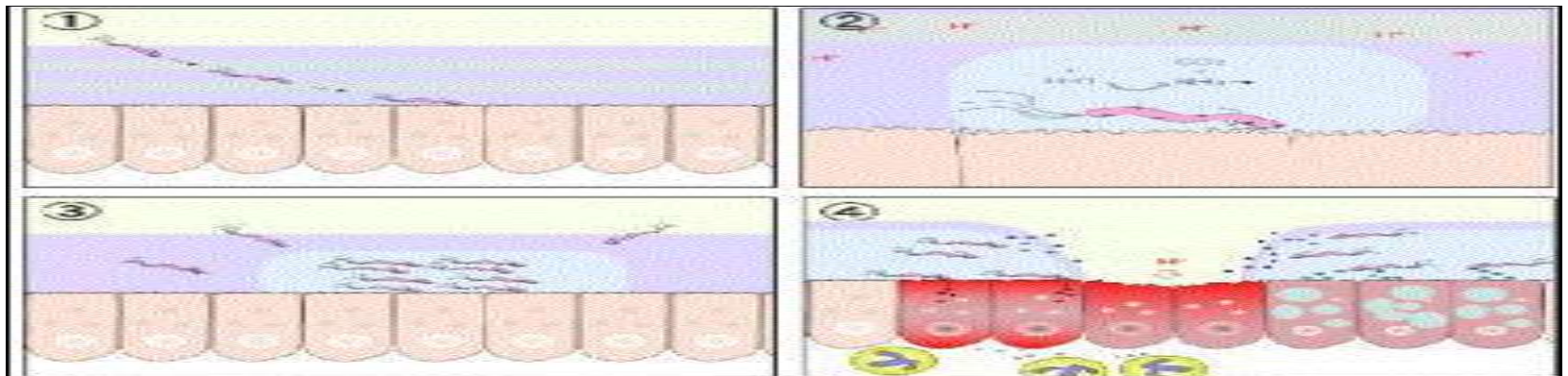
1. Hélicobacter pylori :

- BGN spiralée , possède une forte activité uréasique (urée → ammoniac + CO₂)
- Le seul réservoir est l'homme (antre) , Transmission oro-orale ou féco orale
- Mécanismes physiopathologiques:
 - Virulence bactérienne par altération du mucus et production de médiateurs pro inflammatoires

Réponse inflammatoire → gastrite chronique active → ulcère gastrique

- . Modification sécrétion acide

Développement de métaplasie gastrique dans le duodénum → ulcère duodénal



Enfance tardive

Ingestion de *H. pylori*

Enfance précoce

Gastrite aiguë

Gastrite chronique superficielle

**Gastrite
antrale**

**Pan-
gastrite**

↓ *Somatostatine*

↑ *Gastrine*

↓ *protection
muqueuse*

*H. pylori
cagA+*

*Métaplasie
gastrique*

↓ *Bicarbonates*

**Hypersécrétion
acide**

**Normo-sécrétion
acide**

*H. pylori
cagA+*

*Zones
de faiblesse*

**Duodénite
(*H. pylori*)**

**Lésions
muqueuses**

Ulcère duodénal

Ulcère gastrique

Physiopathologie de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale
secondaire à l'infection à *Helicobacter pylori*.

2. Facteurs génétiques :

3. Tabac :

- Tabagisme excessif (> 15 cig/j) → RR x 2 MUGD, résistance au TRT, favorise récurrence, retarde cicatrisation ;

4. Médicaments gastrototoxiques :

- **Aspirine :**
- **AINS :** Peuvent induire des UG de novo ou réactiver une MUGD. La prise chronique de ces médicaments augmente le risque de survenue d'ulcère et de complications. La survenue est fréquente chez les sujets de plus de 50 ans.

4. Facteurs psychologiques : stress physique et psychique

stress → serait responsable de l'exacerbation de la MUGD.

05. Clinique

01 . Les circonstance de découverte : UG = UD

1. Douleur ulcéreuse typique

- **Type** : crampe
- **Siège** : épigastre
- **Irradiation** : peu, parfois dos
- **Rythme** : postprandiale, nocturne
- Calmée par repas et alcalins
- Périodique dans l' année

Examen clinique normal

2. Douleur atypique

Le siège (hypochondre, région péri ombilicale).

La douleur : une brûlure, une pesanteur.

- Aucune spécificité: Vmts, Dyspepsie, hyperalgique
- Empruntant sémiologie autre organe
- Asymptomatique: sujet âgé
- Complications

06. Examens para-cliniques

- - 01 / FOGD +++ : Confirme le diagnostic +
- - aspect : Perte de substance ronde ou ovale, fond blanc, bords réguliers ou surélevés
- - Siège: Duodénum (bulbe++), estomac (antre, fundus, grande et petite courbure)
- - Permet de réaliser des Biopsies +++
- - Biopsies des berges de l'ulcère gastrique : 8 à 10 Biopsies
- - Pour les ulcères duodénaux et gastriques : Bx antro-fundiques à la recherche de HP.

UD:

Perte de substance +/- profonde

Fond fibrine

Couleur blanc-jaunâtre

Siège: F ant+++

F. post = cpc hgique

Forme: rond 70%

irrégulier 20%

linéaire 8%

salami 2%

Taille: 5-10mm

BIOPSIES selon sydney (HP)

UG:

Bénin: régulier

Rond, ovale

Fond blanchâtre

Bords réguliers

Plis convergents réguliers

Muqueuse avoisinante souple

Malin: Irrégulier

Bords & fond nodulaire

Plis épaissis, orientation

anarchique

Muqueuse avoisinante infiltrée,
dure

10-12 biopsie; 4 cadrants

Contrôle cicatrisation avec biopsies

!!!!!!!ulcère malin peut cicatrisé

Absence cicatrisation

Augmentation taille

Modification aspect

Bx suspecte



CHIRURGIE



Ulcère bulbaire



- Ulcère de l'antre



Ulcère du fundus



Cancer gastrique ulcéré

Tout ulcère gastrique est suspect = Cancer jusqu'à preuve du contraire

Toujours réaliser des biopsies multiples sur les berges de l'ulcère
(pour Dgc différentiel avec Kc ulcéré)

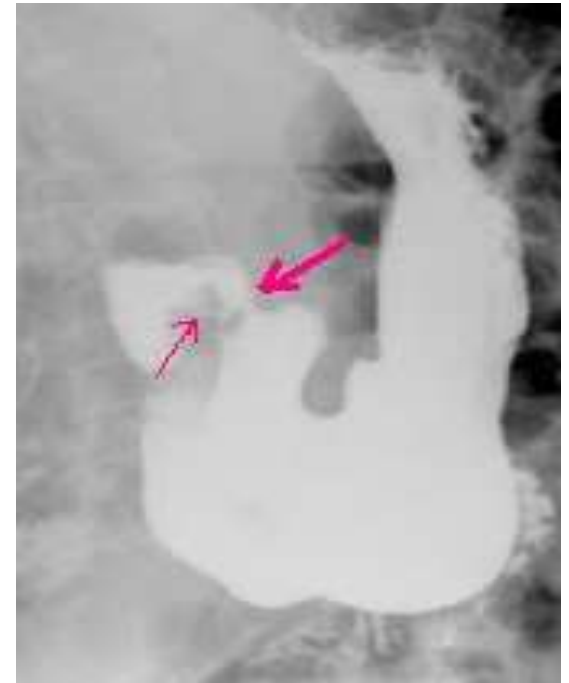
Toujours contrôler un ulcère gastrique après TRT
(les Bx peuvent être faussement négative si beaucoup d'inflammation)

Il n'est pas nécessaire de faire des biopsies sur un ulcère duodénal



- 02 / TOGD +++ :

- Pas d'indication dans le diagnostic de la maladie ulcéreuse non compliquée
- Intérêt dans le diagnostic de l'ulcère sténosant
- image en niche avec fixité de l'image sur plusieurs clichés,
- sténose

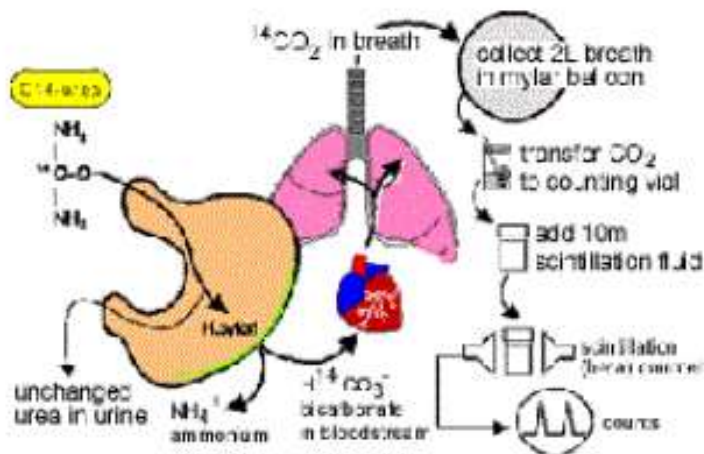


- 03 / Recherche de l'Hp :

Diagnostic d'*H. pylori*

Méthodes Non-invasives

- ✓ Recherche de l'antigène fécal
- ✓ (Sérologie) titrage IgG *H. pylori*
- ✓ Breath Test Urée C¹³ or C¹⁴



Méthodes Invasives

- ✓ **Biopsies gastriques**
- ✓ Test Rapide à l'Urease



07. Formes cliniques

1-symptomatiques

Formes asymptomatiques : apanages des diabétiques et sujets sous AINS.

Formes hyperalgiques : simulant une urgence chirurgicale.

Formes atypiques : caractères de la douleurs

- **2. Formes topographiques**

Ulcères doubles : (10% environ) duodénal et gastrique souvent associés à une hyper- sécrétion acide .

Ulcère de la pointe bulbaire : risque de Sténose

Ulcère bulbaire postéro-inférieur : risque hémorragique

- **3. Formes selon le terrain :**

- **3.1 Sujet âgé** : souvent asymptomatique.

- **3.2 Enfant** : < 7ans ➔ souvent gastrique.

- **4. Formes compliquées.**

Hémorragie

Perforation

sténose

- 5.- Formes étiologiques

Hyper - parathyroïdie :

hypercalcémie stimule la sécrétion de Gastrine

Dg: bilan Phosphocalcique et dosage PTH

Sd Zollinger - Ellison :

secondaire à une Tumeur endocrine pancréatico –duodénale sécrétant la gastrine (gastrinome).

clinique : épigastralgies + diarrhée

Dg : FOGD : maladie ulcéreuse sévère multiple

biologie : hyper- gastrinémie basale , test à la sécrétine +

morphologie : **Echo endoscopie + TDM**

08. Diagnostic

- **1. DC Positif :**

- **MUD** : évoquée par clinique et confirmer par endoscopie.
- **MUG** : évoquée par clinique, confirmée par endoscopie et **histologie**.

- **2. DC Différentiel :**

- devant une douleur épigastrique récidivante :

- - Cancer de l'estomac , du pancréas
- - Colique hépatique
- - Douleurs pancréatique (pancréatite)
- - Origine cardiaque
- Dyspepsie

- devant l'aspect endoscopique :

- cancer gastrique
- maladie de Crohn , sarcoïdose , tuberculose

09. Traitement

- 1.BUTS :
 - soulager la douleur
 - Cicatriser l'ulcère
 - Éradiquer la bactérie ++++
 - Prévention des rechutes
 - Prévention des complications

Moyens

1/Règles hygiéno-diététiques :

- Supprimer tabac
- Eviter médicaments gastrotoxiques, sauf indication incontournable.
- Eviter : stress et aliments qui ↑SGA et irritable à muqueuse (café, épices, boisson acide)
- Déconseiller le jeun de Ramadhan pendant les poussées.

2. Les Antiacides (AA)

- **Principe**

- Effet tampon : consommation des ions H^+
- Effet neutralisant : ↓ SGA et activité de pepsine.

- **2 types d'AA :**

AA	Effet	DCA
Anioniques	Neutralisation	- Carbonate de Ca^{++} - Bicarbonate de Na^+
Non anioniques	Tampon	- Sels d'aluminium - Sels de Mg^{++} - Sels de Al et Mg

- **BENEFICE:** soulage la douleur

3/ TRT anti sécrétoire

A - Antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine :

inhibent la sécrétion acide en bloquant de façon sélective les récepteurs H2 de l'histamine des cellules pariétales de la muqueuse gastrique :

cimétidine 800 mg/j Tagamet®
ranitidine 300 mg/j Azantac®, Raniplex® ;
famotidine 40 mg/j Pepdine® ;
nizatidine 300 mg/j Nizaxid®.

seule prise avant le dîner => réduction de l'acide nocturne : 90%.

- Cicatrise en 4 semaines : 70% des cas.

B - Inhibiteurs de la pompe à protons

Ils bloquent l'activité de l'enzyme $H^+-K^+-ATPase$ ultime maillon du processus sécrétoire de l'acide chlorhydrique qui permet la sécrétion d'ions H^+ du milieu intracellulaire vers la lumière gastrique

oméprazole 20 mg/j Mopral®, Zoltum®

lanzoprazole 30 mg/j Ogast®, Lanzor®

pantoprazole 40 mg/j Inipomp®, Eupantol®

Rabéprazole

ESomeprazole: Inexium

4/ Les protecteurs de la muqueuse

Mécanisme : formation d'un film adhérent à la muqueuse s'opposant à la rétrodiffusion H⁺ et inhibe activité de pepsine → cicatrisation.

A - Prostaglandines:

Aux doses utilisées en thérapeutique
elles ont également un effet antisécrétoire
effets cyto-protecteurs.

contre-indiqués chez la femme enceinte.
misoprostol 800 mg/j Cytotec®.

=> *Diarrhée* : 10%.

B – Sucralfate

4 g/j Ulcar®, Kéal®.

- 5. TRT d'éradication de HP
- LES ATB

	Dose	Résistance
Amoxicilline	2g/j	0%
Clarithromycine	1g/j	17.5%
métronidazole	1g/j	44%
Tétracycline	2g/j	13%
Lévofoxacine	500 mg	3.3% France

Le choix du traitement d'éradication d'HP

Quadrithérapie probabiliste :

IPP + AMOXI + CLARYTHROMYCINE + METRONIDAZOLE + IPP pendant 14 jours

Quadrithérapie bismuthé :

association de tétracycline, métronidazole, bismuth (pylera) :

3 gélules 4 fois/ jour avec un IPP 2 gélules /j pendant 10 jours

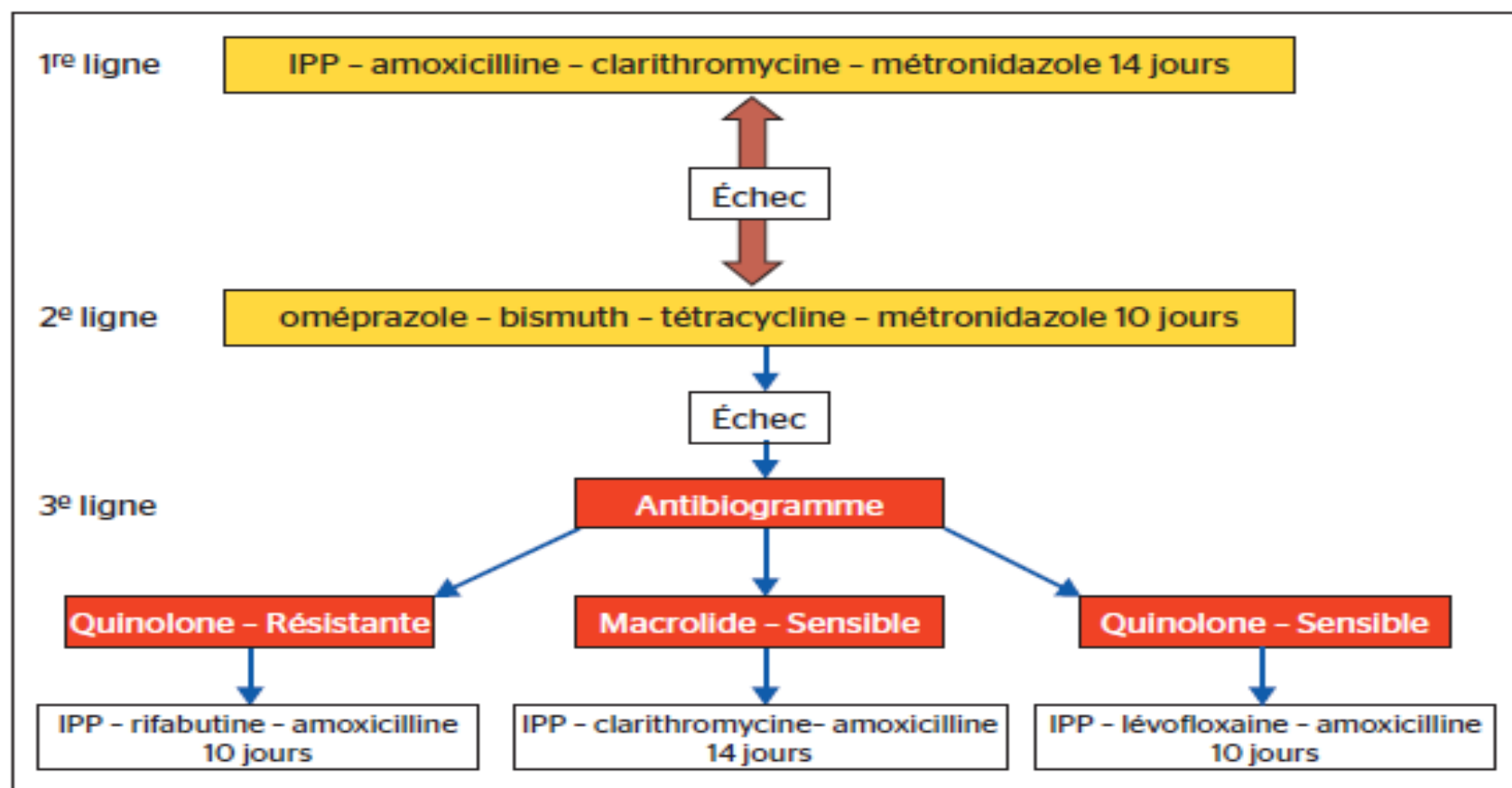


Figure 3. Algorithme de traitement de l'infection à *H. pylori* :
2 quadrithérapies interchangeables en 1^{re} et 2^e lignes,
avec le traitement concomitant ou la quadrithérapie avec bismuth

6//TRT chirurgica : peu de place hormis les ulcères compliqués

ULCERE GASTRIQUE

Indications:

- ☐ Absence de cicatrisation après 12 semaines de traitement bien conduit (et confirmation de l'éradication de HP)
- ☐ Rechutes fréquentes avec un traitement d'entretien
- ☐ Dysplasie sévère sur les berges de l'ulcère

Techniques:

gastrectomie partielle : antrectomie ou gastrectomie des 2/3 avec un rétablissement de continuité par anastomose gastroduodénale ou gastro-jéjunale.

ULCERE DUODENAL

indications :

- o Récidives fréquentes malgré un traitement médical optimal

Techniques :

- o L'opération de choix est une antrectomie avec anastomose gastroduodénale



Anastomose gastroduodénale (Péal)



Anastomose gastro-jéjunale (Finsterer)

3. INDICATIONS :

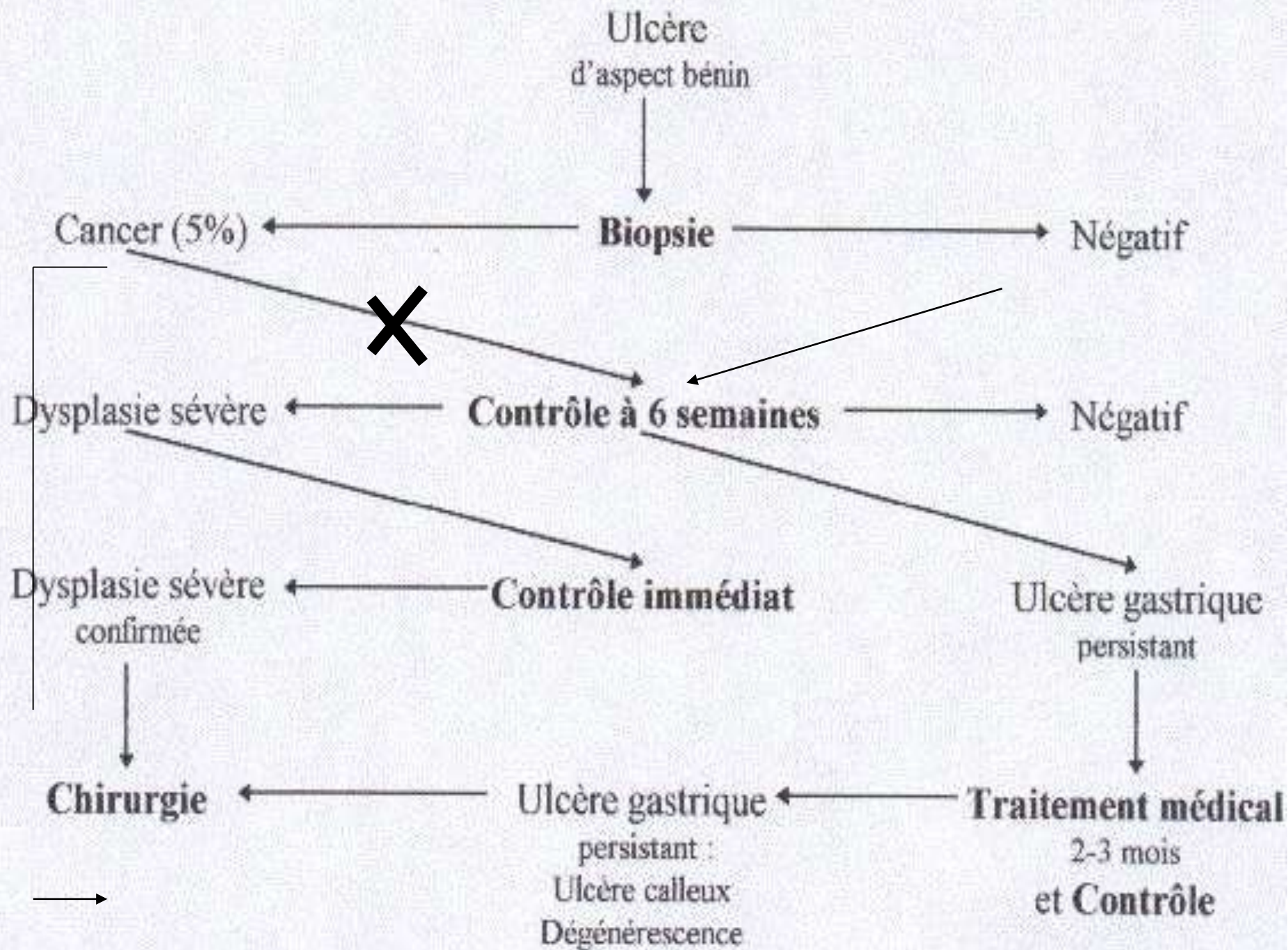
1. UD : -traitement d'éradication d'HP (10 ou 14 jours)

- le contrôle de l'éradication recommandé
- Poursuivre les IPP pendant 3 à semaine si:

- ☐ Ulcere revelée par une complication
- ☐ Patient à risque (prise d'AINS ou aspirine ,agé >65,comorbidités ou persistance des douleurs)

2. UG : - Traitement d'éradication d'Hp + IPP simple dose 3 à 7 semaine

- Biopsies systématiques car risque de cancer
- FOGD de contrôle: 6-8 semaines après (+ biopsie)



CONDUITE PRATIQUE DU TRAITEMENT

- RHD: tabac/AINS/AAS
- Hospitalisation: lors complications ou crise hyperalgique importante
- Les anti-acides ne sont utilisés que comme traitement d'appoint car s'ils soulagent la douleur, ils n'accélèrent pas la cicatrisation:
 - sels d'aluminium (Phosphalugel®) ou de magnésium (Maalox®).
- Éradication Hp

. CONCLUSION

Pathologie fréquente

Parfois : peu symptomatique

Diagnostic positif repose sur la FOGD +++

Traitement est essentiellement médical : Éradication de HP + IPP ,

Arrêter les facteurs favorisants : Tabac , AINS

Risque de cancer si ulcère gastrique (Bx multiples, contrôler cicatrisation)